CARDIOLOGIE

Anatomie

Circulation Sanguine

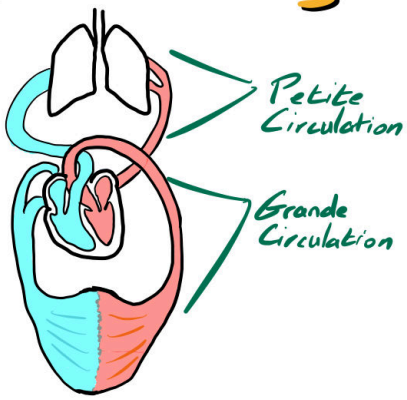
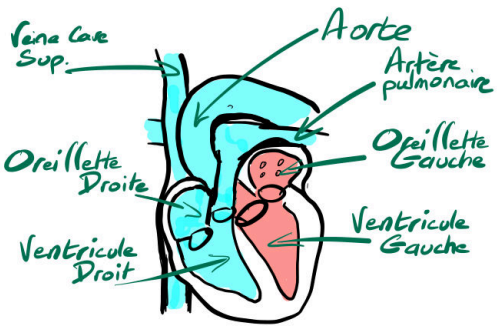
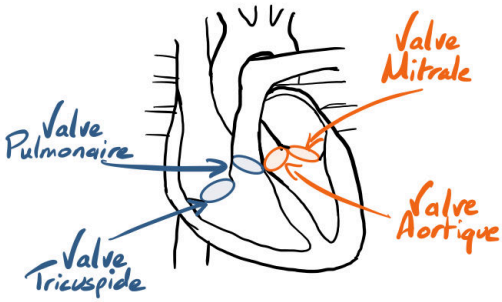


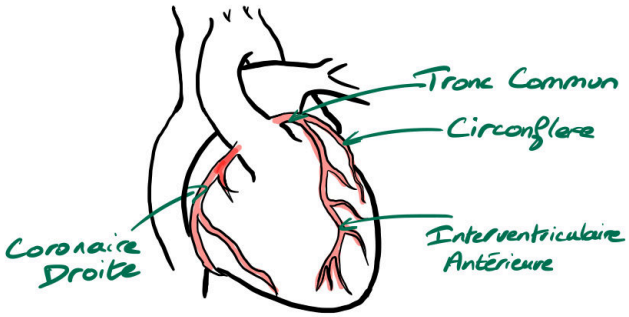
Schéma du Coeur



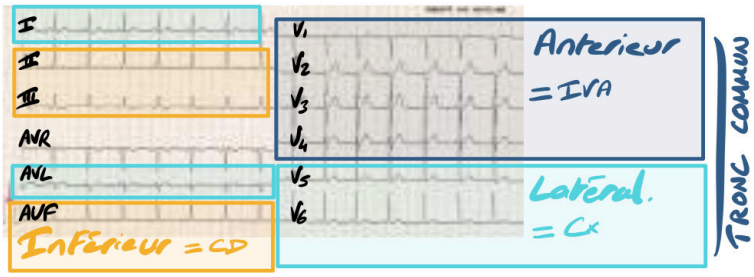
Valves Cardiaques



Anatomie Coronaire

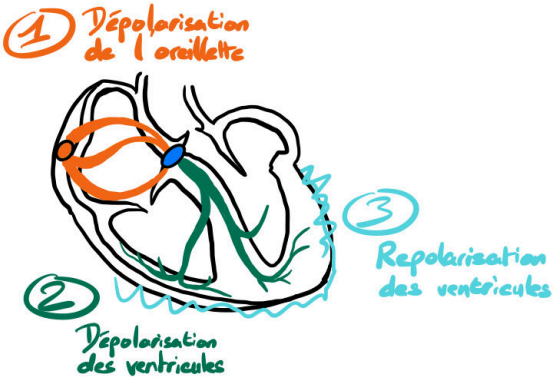


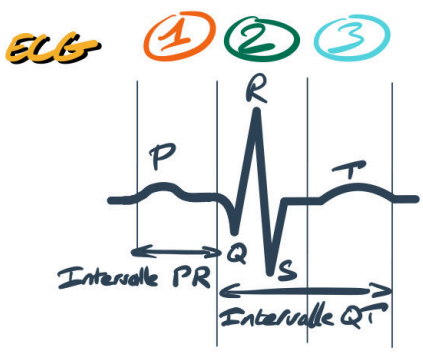
Territoires anatomiques vs. ECG vs. Artères Coronaires



Électrophysiologie







L. SERAUDIE - IFSI CHU de Rouen 2025

CARDIOLOGIE

Rythmologie

Faire un ECG

Précordiales

V_1 = 4e espace intercostal droit, bord droit du sternum
V_2 = 4e espace intercostal gauche, bord gauche du sternum
V_3 = A mi chemin entre V_2 et V_4
V_4 = 5e espace intercostal gauche, ligne mediodaviculaire
V_5 = même ligne horizontale que V_4, ligne axilaire antérieure
V_6 = même ligne horizontale que V_4, ligne axilaire moyenne (sous le bras)



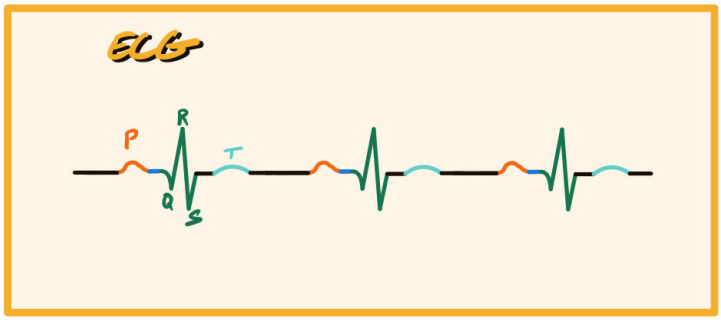
Périphériques

Rouge = bras droit
Noire = jambe droite
Jaune = bras gauche
Verte = jambe gauche

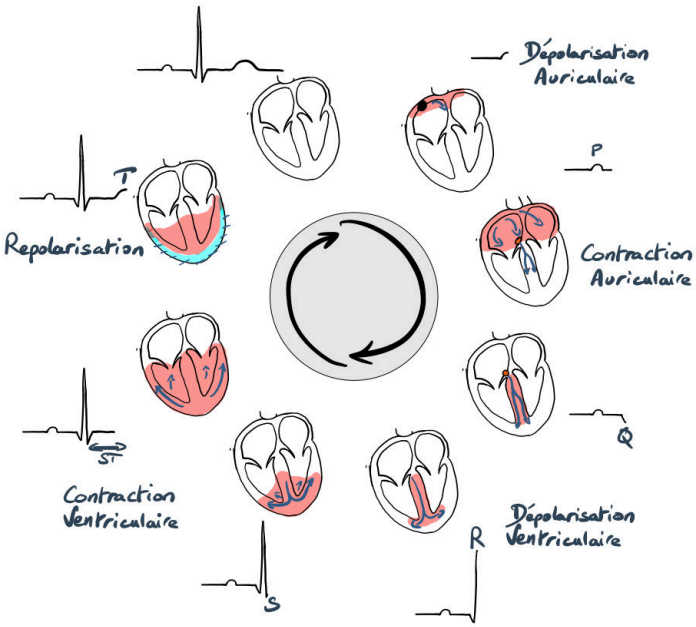


Rythme Sinusal

Chaque onde P est suivie d'un QRS
ET
Chaque QRS est précédé d'une onde P



Cycle Cardiaque



Tachycardie > 100 bpm

Bradycardie < 50 bpm

L. SERAUDIE - IFSI CHU de Rouen 2025

Troubles Du Rythme

Tachycardies Supraventriculaires

Fibrillation Auriculaire

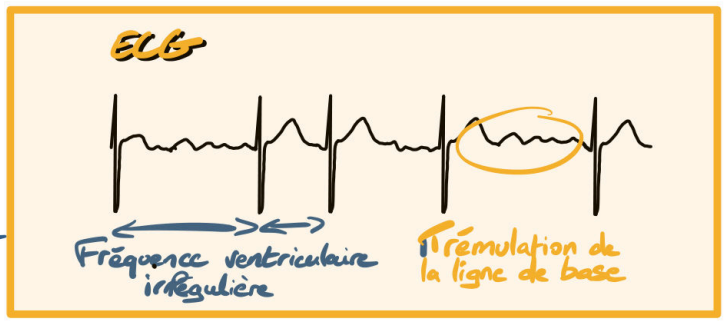


Physio :
- Oreillette en Fibrillation
- Nœud AV joue le rôle de filtre
- Ventricules fonctionnent normalement

Risque : Formation de Thrombus et Insuffisance Cardiaque

Traitements :
- Antiarythmiques + Anticoagulant / risque thrombose
- Choc Elec. Ext.
- Ablation du Trouble.

A l'ECG :
- Pas d'onde P
- Trémulation de l'onde de base
- Fréquence ventriculaire Rapide et Irrégulière



Flutter

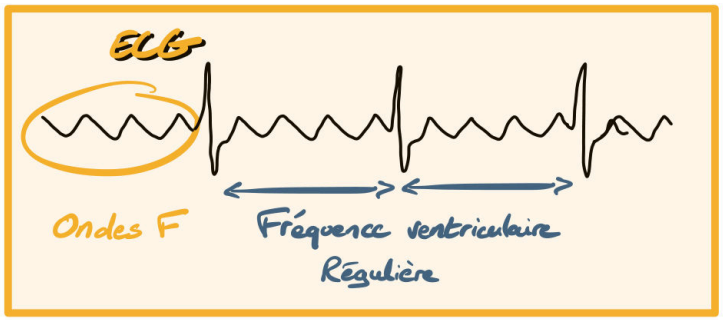


Physio :
- Circuit électrique auriculaire organisé
- Nœud AV. joue un rôle de filtre
- Rythme ventriculaire rapide mais régulier ou irrégulier

Risque : Formation de thrombus et Insuffisance Cardiaque

Traitements : Ablation du trouble + Anticoagulant / risque thrombose
Antiarythmiques

A l'ECG :
- Pas d'onde P
- Onde F en toit d'usine
- Fréquence ventriculaire Rapide et Régulière 2/1, 3/1, ...



L. SERAUDIE - IFSI CHU de Rouen 2025

Troubles Du Rythme

Tachycardies Ventriculaires

Tachycardie Ventriculaire ⚠ Urgence Vitale ⚠

Physio : Rythme auriculaire normal
Fréquence ventriculaire à 180 bpm et + —> Non efficace

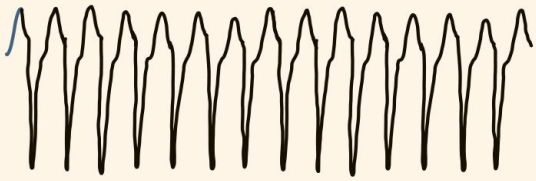


Risque : Perte de connaissance / bas débit
Peut dégénérer en FV

Traitements : CEE en urgence
MCE / DSA / Cordarone
Ablation TV / Sonde de stimulation

A l'ECG : Toute tachycardie régulière à complexe large est considérée comme de la TV

ECG



Fibrillation Ventriculaire ⚠ Urgence Vitale ⚠

Physio : Etat de mort apparente



Risque : Patient mort

Traitements : Débuter la réanimation
MCE / DSA / Cordarone

A l'ECG : Anarchie Totale

ECG

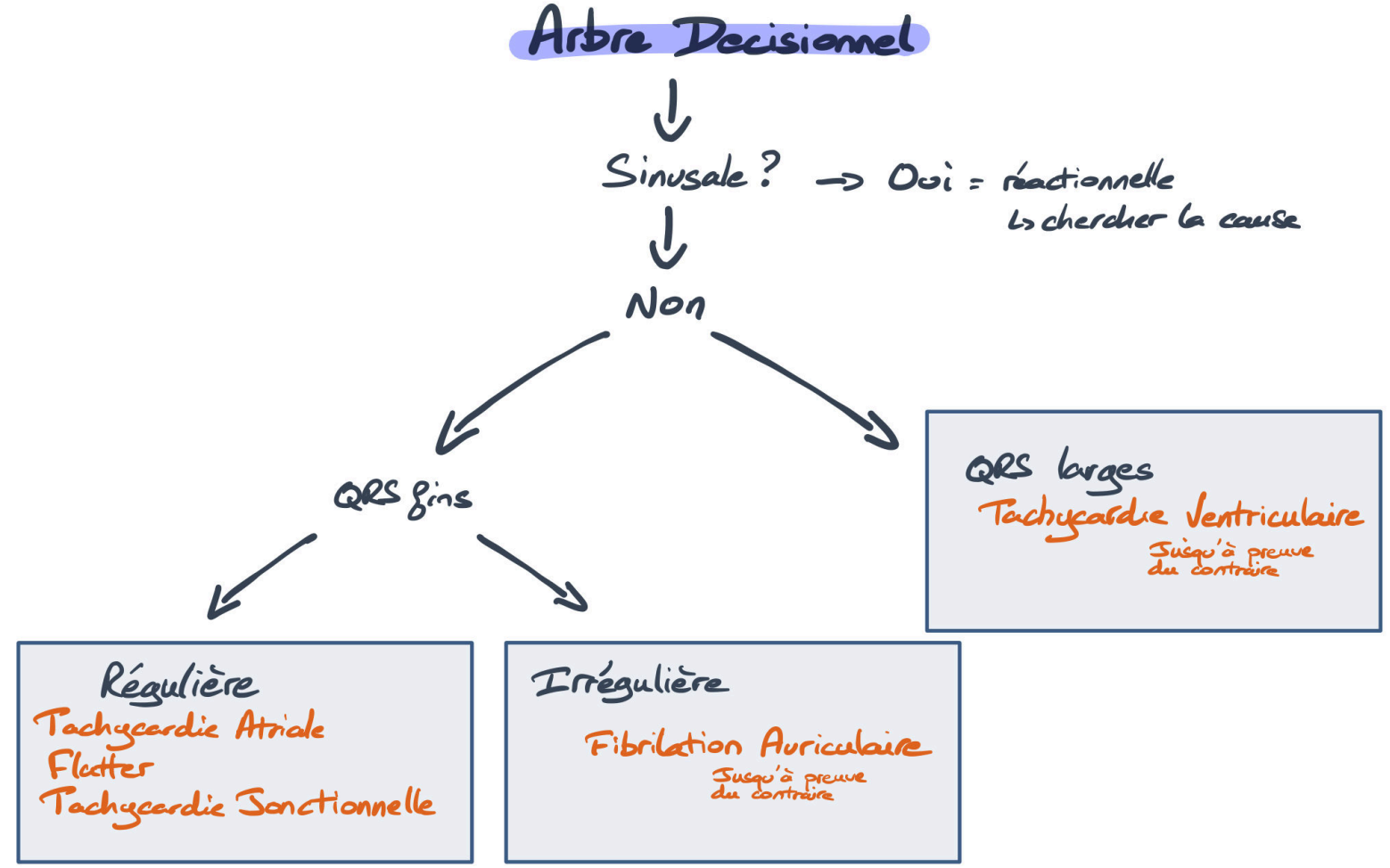


L. SERAUDIE - IFSI CHU de Rouen 2025

Troubles Du Rythme

Tachycardies

Arbre Decisionnel



L. SERAUDIE - IFSI CHU de Rouen 2025

Troubles Du Rythme

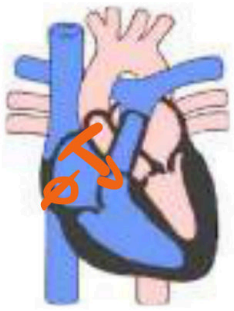
Bradycardies 1/2

Dysfonction Sinusale ⚠ Urgence ⚠

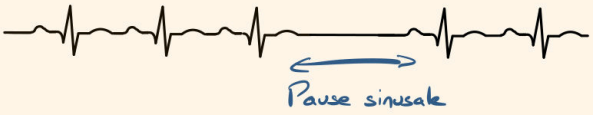
Physio : Anomalie de l'automatisme sinusal
= Pause cardiaque

Risque : Syncope

Traitements : Isuprel dans la phase aigue
Pacemaker si trouble persistant.



ECG



L. SERAUDIE - IFSI CHU de Rouen 2025

Troubles Du Rythme

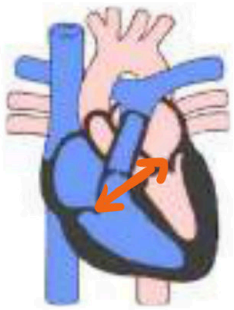
Bradycardies 2/2

Bloc Auriculo - Ventriculaires

Physio : Blocage de la conduction au niveau du Noeud A.V.

Risque : Arrêt Cardiaque (à partir du BAV II)

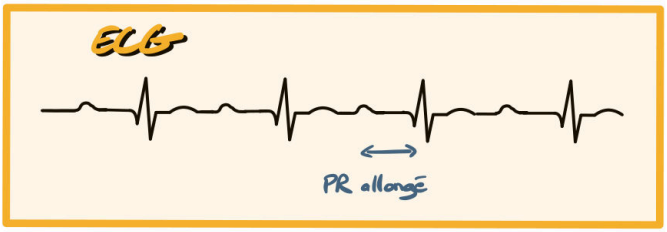
Traitements : Isuprel dans la phase aigue
Pacemaker si trouble persistant



A l'ECG :

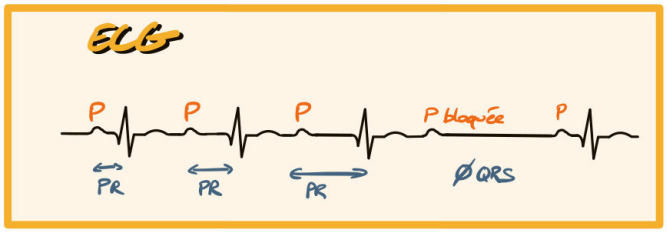
BAV I

Intervalle PR allongé et constant



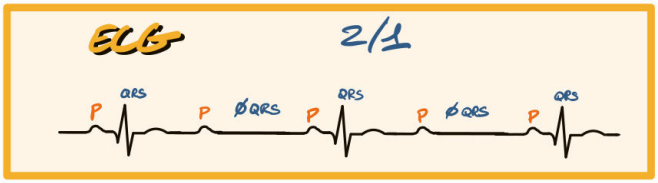
BAV II Mobitz 1

Allongement progressif de l'intervalle PR jusqu'à blocage d'un complexe QRS



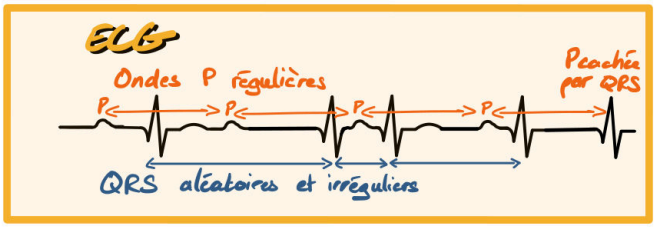
BAV II Mobitz 2 ⚠ Urgence ⚠

Blocage intermittent d'une onde P sans allongement préalable de PR.
(2/1, 3/1...)



BAV III ⚠ Urgence Vitale ⚠

Asynchronisme total entre les oreillettes et les ventricules.
Ondes P et QRS désynchronisées
Plus d'ondes P que de QRS



L. SERAUDIE - IFSI CHU de Rouen 2025